

1 高血圧・蛋白尿・血栓症の薬薬連携 — 家庭血圧をつなぐ

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
① 投与前の血圧・尿蛋白・血栓リスクの評価	家庭血圧の推移 (血圧手帳)	① 家庭血圧の記録を来局ごとに確認
② 降圧薬の選択と休薬・減量基準の確認	尿蛋白・腎機能 (処方箋の検査値)	② 処方箋の尿蛋白・腎機能・血小板数を確認
③ レナリドミドの血栓予防(アスピリン・抗凝固薬)の設定	抗血栓薬の服用状況 (出血症状)	③ 抗血栓薬の服用継続と出血症状の聴取
④ 手術前後のペバシズマブ休薬の管理	むくみ・体重 (電話フォローの結果)	④ NSAIDs・甘草を含む漢方薬など市販薬の確認
⑤ 血栓症・出血発生時の院内対応		⑤ 片足の腫れ・急な息切れは至急受診を伝える

2 家庭での確認と予防・治療

高血圧 患者さんが確認すること 毎日決まった時間に家庭血圧を測る 主な予防・治療 降圧薬(ARB・ACE阻害薬・Ca拮抗薬) 薬局で確認すること 血圧手帳の推移と降圧薬の服用状況	蛋白尿 患者さんが確認すること むくみ・体重増加・尿の泡立ち 主な予防・治療 休薬・減量・ARB・ACE阻害薬 薬局で確認すること 処方箋の検査値(尿蛋白・腎機能)とむくみ	深部静脈血栓症 患者さんが確認すること 片足の腫れ・痛み・色の变化 主な予防・治療 抗凝固薬 薬局で確認すること 症状があれば至急受診。抗凝固薬の服用状況
肺塞栓症 患者さんが確認すること 急な息切れ・胸の痛み・失神 主な予防・治療 抗凝固薬・入院治療 薬局で確認すること 救急受診が必要なことを事前に伝える	抗凝固薬の管理 患者さんが確認すること 鼻血・歯ぐきの出血・黒い便・あざ 主な予防・治療 DOAC・ワルファリン・ヘパリン 薬局で確認すること 腎機能・血小板数、NSAIDsなどの併用	

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サブリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	リバーロキサバン CYP3A4・P-gpの強い阻害	処方薬 イトラコナゾール・ボリコナゾール等	血中濃度↑→出血	他院の抗真菌薬の処方を確認
注意 添付文書 併用注意	抗凝固薬(DOAC) 出血リスクの重複	処方薬 市販薬 NSAIDs・抗血小板薬	出血↑	市販の痛み止めも含めて確認
注意 添付文書 併用注意	タモキシフェン 抗凝血作用の増強	処方薬 ワルファリン	INR↑→出血	INR測定の予定を確認
注意 添付文書 併用注意	レナリドミド ジゴキシンの血中濃度上昇	処方薬 ジゴキシン	ジゴキシンの作用↑	他院の循環器の処方を確認
確認 服薬指導上の 注意	VEGF経路阻害薬 血圧上昇・むくみの増強	市販薬 NSAIDs・甘草を含む漢方薬	血圧上昇・むくみ	市販薬の使用を確認し、相談するよう指導

4 服薬指導タイムライン — 血圧手帳で見守る

① 治療開始前	② 開始～2週	③ 1～3か月	④ レナリドミド・長期服用中
“この薬は血圧が上がりやすいので、今日から毎日、家庭血圧を測って記録しましょう”	“血圧手帳を見せてください。頭痛やめまいはありませんか”	“足のむくみや、尿の泡立ち、急な体重の増加はありませんか”	“片方の足だけが腫れる、急に息苦しくなった時は、すぐに受診してください”
✓薬局で確認 開始前の血圧、降圧薬・抗凝固薬の服用、腎機能	✓薬局で確認 家庭血圧の推移、降圧薬の追加・調整	✓薬局で確認 処方箋の尿蛋白・腎機能、むくみ、体重	✓薬局で確認 抗血栓薬(アスピリン・抗凝固薬)の服用、出血症状
△ここに注意 開始前の血圧コントロールが大切	△ここに注意 160/100以上が続く・強い頭痛は連絡	△ここに注意 むくみ・尿蛋白の増加は処方医へ情報提供	△ここに注意 片足の腫れ・急な息切れは至急受診